

Incontinência urinária · esforço × urgência

Separe incontinência de esforço (tosse/impacto) da de urgência (bexiga hiperativa). Mista é frequente — trate o componente dominante e invista em terapia comportamental.

Avaliação inicial

Lembre - Avaliação inicial

História, exame, EAS/urocultura (excluir ITU), diário miccional. Urodinâmica: antes de cirurgia em casos complexos/refratários — não obrigatória em esforço puro típico.

Classificar pelo gatilho muda a 1ª linha: Kegel/sling versus bexiga hiperativa.



Conduta

- Perda de peso, reduzir cafeína, tratar constipação e tosse crônica
- Fisioterapia do assoalho pélvico (Kegel supervisionado)
- Urgência: oxibutinina/outras anticolinérgicas ou mirabegron
- Esforço refratário: sling miduretral (TVT/TOT) em selecionadas

Red flags

Sinal | Pensar em

Hematúria | Tumor / litíase
Neurológico | Bexiga neurogênica
Fístula | Perda contínua pós-cirurgia/parto
Prolapso avançado | Avaliação uroginecológica conjunta

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não opere esforço sem falha de conservador (salvo exceções). Anticolinérgicos em idosas: delirium e retenção — dose e CI importam.